MAPA DE CONSULTA RÁPIDA · PLANTÃO

Parada Cardiorrespiratória (PCR)

Reconhecimento e atendimento antes da chegada da equipe completa

Reconhecer a PCR — VERIFICAÇÃO

- Sem monitor contínuo: perceber não responsividade ou alteração súbita do nível de consciência ao passar pelo leito.
- Chamado vigoroso pelo nome + contato físico direto.
- Sem resposta: checar pulso central (carotídeo) e respiração ao mesmo tempo, em até 10 segundos.
- **Sem pulso e sem respiração = PCR.**

Chamar Ajuda — ACIONAMENTO

- Gritar **"PARADA NO LEITO XXX"** — dizer o número do leito.
- Aguardar confirmação de que alguém reconheceu a urgência antes de voltar ao paciente.
- Confirmação aciona a equipe multiprofissional (principalmente o médico) e o carrinho de parada.
- Anotar o horário exato da PCR assim que possível.

Fluxo do Atendimento — ALGORITMO PRINCIPAL

1. Sozinho: iniciar compressão torácica — prioridade sobre a ventilação.
2. Ajuda chega: encaixar a prancha (pausa máx. 10s) e revezar — um comprime, outro monta o ambú.
3. Antes da intubação: ventilar com ambú na relação 30 compressões : 2 ventilações.
4. Médico intuba o paciente.
5. Pós-intubação: compressões contínuas + 1 ventilação assíncrona a cada 6 segundos.
6. A cada troca de compressor (2 min): checar o pulso.
7. Pulso retornou: manter ventilação até conectar ao ventilador e obter acesso venoso.
8. Equipe completa: enfermeiro monitoriza, médico avalia o ritmo e decide a conduta (ex.: choque).

Parâmetros-Alvo — METAS

- Profundidade: 5 cm (paciente adulto).
- Frequência: 100–120 compressões/min.
- Retorno total do tórax entre compressões.
- Revezar a compressão a cada 2 minutos.
- 30:2 antes da intubação · 1 ventilação/6s depois.

Técnica e Raciocínio — CLÍNICO

- Cantar mentalmente uma música no ritmo certo ajuda a manter a frequência da compressão — ex.: "Stayin' Alive" (Bee Gees), "Virgo's Groove" (Beyoncé), "Baby Shark", "Bad Romance" (Lady Gaga).
- Vedação da máscara com a técnica "C-E": mão em C segura a máscara, dedos em E sustentam o queixo.
- Com 2 pessoas: uma veda a máscara com as duas mãos, a outra aperta o ambú.
- Quem encontra o paciente tem papel decisivo — não espera a equipe chegar para agir.
- **A compressão torácica é o que salva a vida do paciente.**

Nunca Faça — PROIBIÇÕES

- Nunca checar pulso periférico — só o central (carotídeo).
- Nunca pausar a compressão por mais de 10 segundos, nem para a prancha.
- Nunca ultrapassar 2 minutos comprimindo sem trocar.
- Nunca medicar ou desfibrilar antes da avaliação do ritmo pelo médico.

Material de apoio para consulta rápida durante o plantão · baseado na aula sobre PCR na enfermaria

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos